Traitement de la maladie persistante ou récidivante

À RETENIR

- **Récidive** : maladie chez un patient classé en rémission complète ; **maladie persistante** (plus fréquente) : jamais classé en rémission complète.
- Biologiquement détectable : Tg **> 0,2 ng/ml** sous traitement et/ou Tg stimulée **> 1 ng/ml** et/ou Ac anti-Tg ⊕ ou en ascension.
- Rémission complète → récidive **< 5 %** (2 % FR, 2 % RI, 14 % HR) ; sinon rechute **13 % / 41 % / 75 %** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle HR 79 % (Tuttle 2010)*.
- Maladie biologique isolée : 2e traitement par **3,7 GBq (100 mCi)**, de préférence en sevrage, si Tg stimulée **> 10 ng/ml** (sevrage) ou **> 5 ng/ml** (TSHrh), Tg basale ↑ **> 50 %**, temps de doublement **< 1 an**, Ac anti-Tg ↑ **> 50 %**.
- TEP FDG = indication de choix dans la maladie biologique isolée.
- Maladie avec cible morphologique/métabolique : traitement local (chirurgie, RTE…) puis selon Tg résiduelle et RCP.
- TEP ⊕ → peu ou pas répondeur au traitement iodé.
- Balance bénéfice/risque (cancers secondaires) à évaluer au-delà de **22,2 GBq (600 mCi)** cumulés.

I. Définitions

- **Récidive tumorale** : présence d'une maladie survenant chez un patient classé en rémission complète.
- **Maladie persistante** : plus fréquente ; survient chez un patient n'ayant jamais été classé en rémission complète depuis la PEC initiale :
  - cliniquement détectable ;
  - biologiquement détectable : Tg **> 0,2 ng/ml** sous traitement, et/ou Tg après stimulation **> 1 ng/ml**, et/ou Ac anti-Tg ⊕ ou en ascension, et/ou temps de doublement [court] ;
  - maladie détectable en dehors de la loge thyroïdienne sur la scintigraphie post-thérapeutique lors de la totalisation isotopique ;
  - maladie détectable par un autre moyen d'imagerie : EC, TDM, IRM, TEP.

II. Risque de rechute selon la classification dynamique

Groupe de risque initial	Si rémission complète (risque < 5 %)	En l'absence de rémission complète (risque 15/20 % → > 20 %)
Faible risque (FR)	**2 %**	**13 %**
Risque intermédiaire (RI)	**2 %**	**41 %**
Haut risque (HR)	**14 %**	**75 %** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 79 % (Tuttle 2010)*

III. Différentes stratégies en cas de maladie persistante ou récidivante

1. Maladie biologique sans cible morphologique ou métabolique (TEP FDG ⊖)

- Décision selon le seuil de Tg basale et/ou stimulée, et la positivité et la cinétique des ATg :
  - Tg **< 5** sous TSHrh ou **< 10** après stimulation endogène → **surveillance et cinétique de la Tg** ; puis si Tg **> 5 ng/ml** sous TSHrh, Tg **> 10 ng/ml** sous stimulation, Tg en augmentation sous LT4, ou Ac anti-Tg ↑ **> 50 %** → iode 131 ;
  - Tg **> 5 ng/ml** (TSHrh), Tg **> 10 ng/ml** (sevrage), Tg basale ↗, ATg ↑ **> 50 %** → **iode 131 : 3,7 GBq** en sevrage / TSHrh.

2. Maladie biologique avec cible morphologique ou métabolique

1. **Traitement local** : chirurgie, RTE ou autre.
2. Puis selon la Tg résiduelle et la RCP.
3. Surveillance et **cinétique de la Tg**.
4. Si Tg **> 5** sous TSHrh, Tg **> 10** en sevrage, Tg basale en ↑ **> 1**, Ac ↑ **> 50 %** → **iode 131 : 3,7 GBq** en sevrage / TSHrh.

IV. Indications de l'iode 131

1. En cas de maladie biologique isolée

Un **deuxième traitement par l'iode** est préconisé avec une activité empirique de **100 mCi (3,7 GBq)**, préférentiellement **en sevrage** (TSHrh si contre-indication liée à une comorbidité générale), devant :

- taux de Tg stimulée **> 10 ng/ml** en sevrage ou **> 5 ng/ml** après TSHrh ;
- taux de Tg basale en progression **> 50 %** ou **> 1 ng/ml** ;
- temps de doublement **< 1 an** ;
- apparition d'Ac anti-Tg ou leur augmentation progressive **> 50 %** avec la même technique de dosage.

> **NB** — TEP → **indication de choix**.

2. Maladie biologique associée à des anomalies en imagerie morphologique ou fonctionnelle

L'administration d'une activité thérapeutique d'^{131}I est discutée à visée :

- à la fois **diagnostique** : pour connaître le caractère iodofixant ou non ;
- et **thérapeutique**, en particulier lorsque les cibles identifiées sont iodofixantes, multiples, ou de petite taille, notamment :
  - maladie ganglionnaire **< 1 cm** ;
  - petite métastase viscérale et/ou osseuse.
- → Les données (du balayage post-thérapeutique, BPT) peuvent éventuellement être utilisées pour guider et optimiser une reprise chirurgicale avec détection peropératoire.

3. Après un traitement chirurgical et/ou une radiothérapie externe de métastases ganglionnaires ou de la loge thyroïdienne (maladie récidivante ou persistante)

Au moins un traitement par l'iode 131 peut être préconisé, avec une activité empirique de **3,7 GBq**, préférentiellement en sevrage, si après traitement local d'une maladie persistante/récidivante il y a persistance d'une **maladie biologique résiduelle**, associée ou non à une maladie morphologique.

4. En cas de maladie locorégionale non résécable

- Au moins un traitement à l'iode 131 est préconisé avec une activité empirique de **3,7 GBq**, préférentiellement en sevrage.
- Dans un objectif de **réduction ou de destruction tumorale** par la répétition d'activités thérapeutiques sur une maladie iodofixante, ± traitement local.
- La répétition du traitement doit tenir compte de :
  - la captation de l'iode 131 par les cibles à traiter ;
  - leur volume ;
  - la réponse au traitement sur le plan biologique, morphologique et métabolique ;
  - l'apparition de nouveaux sites métastatiques ;
  - le résultat de la TEP FDG : **TEP ⊕ → peu ou pas répondeur au traitement iodé**.

> **NB** — La balance bénéfice/risque de **cancers secondaires** qui pourraient être liés à la répétition des traitements par ^{131}I doit être évaluée au-delà d'une activité cumulée **> 22,2 GBq (600 mCi)**.

5. En cas de métastase

→ Voir la fiche « Traitement des formes métastatiques ».

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Différence entre récidive et maladie persistante ?	Récidive : patient préalablement en rémission complète ; persistante : jamais classé en rémission complète.
2. Critères biologiques de maladie persistante ?	Tg > 0,2 ng/ml sous traitement, Tg stimulée > 1 ng/ml, Ac anti-Tg ⊕ ou en ascension.
3. Risque de récidive en cas de rémission complète selon FR / RI / HR ?	2 % / 2 % / 14 %.
4. Quand proposer un 2e traitement par ^{131}I dans une maladie biologique isolée ?	Tg stimulée > 10 (sevrage) ou > 5 ng/ml (TSHrh) ; Tg basale ↑ > 50 % ; temps de doublement < 1 an ; Ac anti-Tg ↑ > 50 %.
5. Quelle activité empirique est utilisée ?	3,7 GBq (100 mCi), de préférence en sevrage.
6. Que signifie une TEP FDG ⊕ pour le traitement iodé ?	Peu ou pas répondeur au traitement par l'iode.
7. Au-delà de quelle activité cumulée réévaluer le bénéfice/risque ?	22,2 GBq (600 mCi).